جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : منال سيد درويش محمد
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** الدرب الاحمر **العنوان :** 59 ح الجنبكيه
رقم البطاقة : 26607210103384 **رقم التليفون :** 01020785881 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 21-07-1966 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبطات الاروماتيز [14161] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: منال سيد درويش محمد
National ID: 26607210103384

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

National Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : [redacted]
2-ID number: 26607210103384

Sex: Female
3- Medical number: 83100740
Old Med : 1981/2023
Patient Age : 52 Y
BIL MRM

HDT 1194

Family history
marital status
Co morbidity HTN
Phone 01222692994
NRS Score
Menopausal status POSTMENOPAUSAL
BMI
GROUP
REASON OF MDT NEW
Date of MDT 2023-07-11

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup : FREE

BX:	ER:	PR:	Her 2 Neu :	SISH :	KI67 :
DCIS					
RT POST NRM	8/8	4/8	+VE		
RT	8/8	3/8	+VE		
LT					

T	N	M
RT CT4D	1	0
LT CT4D	3	0

Sonomammography

PATIENT HISTORY
PATIENT RECEIVED NACT TCHX6 , NAVELIBINE CARBO HERCEPTI PERJETAX 2 THEN BILATERAL MRM RT,LT, NO NIPPLE AND AREOLA INVOLVMENT,,RT LNS 0/17,,FREE RESECTION MARGIN LT LNS 0/16

MDT OUTCOME & PLAN

1- PORT
2- CONTINUE ADJUVANT HERCEPTIN PERJETA
3- ADJUVANT AIX 5 YEARS

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

out:b'ank

Name: منال سيد درويش **MR. :** 1521	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The attending note indicates that no clinical data are currently available. The record references a bilateral magnetic resonance mammography (MRM) performed in June 2024 with Aramidex and supportive therapy, as well as a three-month follow-up computed tomography of the chest, abdomen, and pelvis (CT CAP). The patient is requested to return for the next visit on 8 November 2026.

تحريرا في ,

التاريخ :	**20-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : نهي سعيد علي محمد

يعتمد ,

atient Name	: الأستاذه / منال سيد درويش	Request No.	: 13004483
Patient No.	: 4047-2022	Request Date	: 19/06/2023
Path No.	: 1981/23	Verification Date	: 25/06/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - فئة الدولة
Age	: 56 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

(therapy effect).
* Additional pathologic findings: N/A.

Diagnosis:
Bilateral breast cancer post NACT, MRM specimen:
* No viable tumour tissue in previously diagnosed carcinoma.
* No Ductal carcinoma in situ.
* Free nipple and areola.
* Lymph node involvement of Right MRM: Free (0/17).
* Lymph node involvement of Left MRM: Free (0/16). All lymph nodes were hyalinosed (therapy effect).
* Free resection Margins.
* Complete pathological response.
* Stage: ypT0 , ypN0.

Signature
Prof. Dr. Lubna Omar.
Dr. Menna Nabil.

Verified by :
DR.Menna Nabil

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: Ms. Manat Sayed Darweesh

Date: 24.9/2022 ID:2222059450 Acc.:4700087

Referring Prof. Dr. Mostafa Nasr Ibrahim / الأستاذ الدكتور مصطفى نصر ابراهيم

Digital 3D soft tissue mammography & tomosynthesis with ultrasound examination of both breasts, revealed:

Indication: left palpable breast lump.

ACR C).

- Left breast shows multiple irregular marked dense mass lesions scattered at all the breast area associated with architectural distortion, overlying marked skin thickening and suspicious amorphous micro-calcification within and among the lesion.
- Tomosynthesis revealed more coalesced irregular mass lesions in the left breast.
- No right suspicious micro-calcific clusters.
- Normal right skin thickness and contour.
- Normal right areola / nipple complex.

Ultrasonography examination showed:

- The left breast shows lower outer quadrant and retroareolar ill-defined irregular hypoechoic solid mass lesion with posterior shadowing (index mass lesion) measuring 3.5 cm. Another smaller similar multiple innumerable lesions scattered at all the breast.
- Marked skin thickening up to 12 mm with hypoechoic round lesion measuring 1 cm (likely metastatic skin lesion).
- No right cystic or solid masses.
- No micro-irregular dilated ducts noted.
- Left multiple atypical (five) pathological axillary lymph nodes at level I and II, the largest shows cortical thickening with mullted hilum and measures 2.5 X 1.7 cm.
- Enlarged Left supra-clavicular lymph node measures 1.3 cm.
- Right axillary enlarged lymph node with focal cortical thickening up to 2 cm at level I.

Impression:

- Multicentric malignant mass lesions with ipsilateral pathological axillary lymph nodes (BIRADS 5).

Recommendation:

- Tru cut biopsy from the left malignant index lesion.
- Dynamic MRI study for bilaterality.
- FNAC from enlarged right axillary lymph node.

Yours truly
Dr. Lamiaa Adel, MD
Breast imaging & intervention consultant

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Dokki Scan

Dr.Salwa Fathy
Prof. Radiodiagnosis - Cairo Univer
Dr. Ahmed Fathy
Consultant Radiodiagnosis
Dr. Hatem Abou El Abbas
Prof. Radiodiagnosis - Theodor Bilh

Patient Name:	*Manal Sayed Darweesh*	*Patient ID:*	*554568*
Prof. Dr:	*Center harmal*	*Exam Date:*	*16/11/2022*
Accession:	*221116198*		

99mTc-MDP BONE SCAN

Desired information:

- skeletal surveying.

Technique:

- Anterior and posterior Delayed Whole body bone scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99mTc-MDP.

Report:

Delayed static phase:-

- Degenerative changes are noticed in the dorsal and lumbar vertebrae.
- Arthritic changes at knees and shoulders.
- Otherwise the rest of the surveyed skeleton is free from serious bone lesions.
- Both kidneys are visualized with marked retained activity at the right side for U/S correlation

Conclusion:

- *No definite evidence of metastatic bone deposits.*

Thanks;
Nuclear Dr. Huda Moustafa, MD

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar-El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
إدارة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Manal Sayed Darwish Mohamed	Date : 19/07/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 57 Year(s)
Medical ID: 4047/2022	

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

Case of bilateral breast cancer underwent bilateral mastectomy shows:

- Status post bilateral mastectomy.
- Left operative bed shows diffuse skin thickening with underlying subcutaneous edema, edematous muscles as well as fat stranding and large seroma measuring about 10.3x2.6 cm.
- Right operative bed shows multiple air loculi with surrounding moderate edematous changes evident by subcutaneous fat standing, skin thickening and edematous changes of the related muscles with surgical emphysema of the right aspect of the chest wall.
- Bilateral few subcentimetric pulmonary nodules the largest is seen at the right lower lung superior segment measuring about 6 mm.
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Right side porta cath is noted.
- Skeletal examination revealed:
    - Tiny sclerotic foci seen at the D7 inferior vertebral end plate likely degenerative.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

atient Name	: [illegible]	Request No.	: 13000739
atient No.	: 28607210103384	Request Date	: 15/10/2022
ith No.	: SR- 788/22	Verification Date	: 01/11/2022
ex	: Female	Financial Category	: [illegible]
ge	: 53 Y	Department	: Out Patient
eferring Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: marwa mohamed youssef

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

nical Data:
ft breast cancer.

ature of the specimen:
ide revision.

oss Examination:
ne block labelled by (2025/115).
IC technique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA
tem for ER, PR,HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).
roscopic examination:
istological type: Invasive duct carcinoma.
rade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): GII (3+2+1).
Duct carcinoma insitu: minimal.
rineural invasion: No.
Lymphovascular emboli: No.
T (Positive control showed appropriate reactivity) :
R: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)
R: Weak nuclear reaction in 4% of tumor cells (Allred score 3/8)
ER2: Strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+)
67: 35 % nuclear reaction of tumor cells

nosis:
breast cancer, Slide revision:
asive duct carcinoma GII with minimal DCIs.

Positive (score 8/8).

Verified by :

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

atient Name		Request No.	13001259
atient No.	26607210103384	Request Date	17/10/2022
ath No.	3083/22	Verification Date	02/11/2022
ex	Female	Financial Category	
ge	56 Y	Department	Out Patient
eforreing Doc.			
		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

:
: Positive (score 8/8).
: Positive (score 4/8).
:R-2: Positive (score 3+)
7: Positive in 50% of tumor cells.

f.Gamal Abdelatty
Esraa Magdy

Verified by :
dr.esraa magdy

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]